

Introduzione al modulo di Salute mentale — Sintesi

Salute mentale · Sessione 01

Salute, benessere e normalità sono piani diversi: distinguerli permette di comprendere la persona senza ridurla a diagnosi, sintomo o deviazione dalla media.

Struttura del modulo

- Tre tappe: **clinica, mondo, corpo**.
- Quattro dimensioni trasversali: spazio, tempo, identità, incontro.
- **Clinica**: dal greco *klinein*, chinarsi sul patire dell'altro.
- L'operatore sociale è un **trait d'union** tra discipline e ricomponere lo sguardo sulla persona.
- Presa in **cura**, non semplice presa in carico.

Salute, benessere, normalità

- **Salute** → funzionalità e potenzialità.
- **Benessere** → vissuto soggettivo e qualità della vita.
- **Normalità** → conformità a media, ideale o funzionamento abituale.
- Fuori dalla norma non significa malato; salute e benessere possono non coincidere.

Disease, illness, sickness

- **Disease** → condizione biomedica misurabile e certificabile.
- **Illness** → esperienza soggettiva della persona.
- **Sickness** → riconoscimento sociale, ruolo di malato, stigma.
- Le tre dimensioni possono combinarsi o non coincidere.

- Per il lavoro sociale, lo stigma modifica concretamente accesso all'aiuto e benessere.

Boorse: sette criteri insufficienti

Christopher Boorse, 1977 mostra che nessun criterio definisce da solo salute o malattia:

1. **Valore** → desiderabilità relativa a persona e contesto.
2. **Trattamento medico** → non tutto ciò che il medico tratta è malattia e non tutte le malattie sono trattate.
3. **Norma statistica** → frequente non equivale a sano; raro non equivale a patologico.
4. **Sofferenza** → malattie asintomatiche e dolori fisiologici.
5. **Disabilità** → assenza di un'abilità non equivale sempre a malattia.
6. **Adattamento** → anche l'ambiente può e deve adattarsi alla persona.
7. **Omeostasi** → vita, crescita e movimento rompono continuamente l'equilibrio.

La salute è un processo dinamico; equilibrio immobile significa rigidità.

Benessere

Le sei dimensioni di **Carol Ryff**:

- **Autoaccettazione** → riconoscere qualità, limiti e percorso.
- **Relazioni positive** → fiducia, calore, affetto, reciprocità.
- **Autonomia** → regolazione indipendente dalle pressioni.
- **Controllo ambientale** → usare opportunità e risorse.
- **Percezione di crescita** → sentirsi in sviluppo.
- **Scopo nella vita** → mete e significato.

Continuum di Fulcheri:

Condizione	Indicatore
Benessere	Bisogni e qualità di vita sufficientemente soddisfatti
Disagio	Sofferenza senza sintomi specifici
Malessere	Sofferenza più intensa e consapevole, anche corporea
Disturbo	Sintomi clinici e comportamento alterato
Malattia mentale	Alterazioni persistenti e stabilizzate

Tre normalità

- **Statistica** → confronto con la media; dipende da gruppo e cultura.
- **Di valore** → confronto con un ideale; può diventare penalizzante.
- **Individuale** → confronto con il proprio funzionamento precedente.
- **Il contesto cambia il significato del comportamento.**
- Non sempre è utile restaurare la normalità precedente: può servire costruirne una nuova.

Posizione davanti alla malattia

Due assi:

- **Identificazione** → condizione estranea oppure parte di sé.
- **Agentività** → partecipazione attiva oppure passività e delega.

Posizione	Profilo
Combatto	Non identificato + agentivo; vuole eliminare la condizione
Guarisci-mi	Non identificato + passivo; delega la guarigione
Mi curo	Identificato + agentivo; cerca benessere nella condizione
Cura-mi	Identificato + passivo; delega il miglioramento

- Parte agentiva → **area dell'alleanza.**

- Parte passiva → **area della delega**.
- **To cure** = terapia e guarigione.
- **To care** = cura della persona e del benessere.
- La cura rimane possibile anche senza guarigione.

Salute mentale

- Parte inseparabile della salute generale.
- Non è sola assenza di disturbo.
- Comprende benessere, realizzazione, gestione delle difficoltà, lavoro e partecipazione comunitaria.
- Dipende dall'interazione tra predisposizione, biografia, comportamento, relazioni, cultura, economia, politica e ambiente.
- Il comportamento va letto nel contesto.
- Il disturbo può coinvolgere rapporto con sé, con gli altri e comprensione reciproca.
- **Carta di Ottawa, 1986**: salute come risorsa quotidiana, non obiettivo finale.

Linguaggio e stigma

- **Matto** → condotta percepita come incontrollata.
- **Follia** → vuoto e perdita di senso.
- **Pazzia** → sofferenza e furia.
- **Alienato** → estraneità ed esclusione.
- **Delirio** → uscita dal solco, deviazione.
- Dire "è schizofrenico" fonde diagnosi e identità; "persona con schizofrenia" mantiene la distinzione.
- L'apparente non-senso può indicare un limite dell'osservatore, non assenza di significato.

Swiss Public Health Conference

Olten, 21-22 agosto 2014. Tag **P-I-C-S**:

- **Processo** → sviluppo e gestione continua delle difficoltà.

- **Interdipendenza** → non c'è salute senza salute psichica; fisico, psichico e sociale sono inseparabili.
- **Complessità** → interazione di fattori individuali, biografici, culturali, sociali e ambientali.
- **Sfida permanente** → ogni età può attivare risorse o disturbi; il sostegno incide sul percorso.

Tragedia e lavoro sociale

- Tragedia greca → sofferenza e follia diventano esperienza pubblica e condivisa.
- **Catarsi** → incontro ed elaborazione delle emozioni.
- Eschilo: follia dagli dèi; Sofocle: tragicità della vita; Euripide: tragedia delle relazioni.
- Le cinque tragedie del 2026 convergono sulla violenza contro le donne in guerra.
- Attività: leggere, discutere, sintetizzare, mettere in scena.
- Collaborazione con il **Club '74** basata su reciprocità e incontro.
- Il lavoro sociale ha una dimensione politica nelle scelte quotidiane di inclusione, ascolto e partecipazione.

Da ricordare: salute, benessere e normalità non coincidono; la salute mentale è un processo relazionale e contestuale; **to care** resta possibile anche quando **to cure** non lo è.